

Основным путем распространения туберкулезной инфекции на мочеполовую систему является {

~контактный

=гематогенный

~лимфогенный

~интраканаликулярный

}

Туберкулезные изменения в почке локализуются преимущественно {

~в мозговом слое

=в корковом слое

~в чашечно-лоханочной системе

~ в паренхиме

}

Частота поражения мочеполовой системы туберкулезом составляет {

~около 10%

~около 5%

=около 2.5%

~около 1.5-2.0%

}

Сочетание туберкулеза мочеполовой системы со специфическими поражениями других органов {

~не наблюдается

=наблюдается нередко

~иногда встречается

~часто встречается

}

Наиболее частой формой туберкулеза мочевой системы является {

~туберкулезный папиллит

~фиброзно-кавернозная

~кавернозная

=паренхиматозная (туберкулез почечной паренхимы)

}

Наиболее характерными для туберкулеза мочевой системы клиническими признаками являются {

~ноющие боли в области поясницы

~изменения в моче в виде гематурии ~острая боль в животе

~субфебрилитет

=изменения в моче в виде лейкоцитурии

}

Симптомы интоксикации для клинического течения нефротуберкулеза {

~характерны

~не характерны

=встречаются не всегда

~ часто встречаются

}

Основными методами выявления туберкулеза мочевой системы являются {

~рентгенологический

=микробиологический

~туберкулиновых проб

~клинический

}

Среди инструментальных методов исследования наибольшее значение для распознавания туберкулеза мочевого пузыря имеет {

~ретроградная пиелография

=цистоскопия

~внутривенная урография

~инфузионная урография

~хромоцистография

}

Внутривенная урография для диагностики туберкулеза почек {

~является единственным методом диагностики

=не является единственным методом диагностики

~является малоэффективным методом диагностики

~ не применяют для диагностики

}

С целью определения нарушения функции почек радиоизотопная ренография {

=может быть применена

~не применяется

~применяется иногда

~ малоинформативна

}

О функциональном состоянии почек наиболее полное суждение может быть получено с помощью {

~анализа мочи

~анализа мочи по Нечипоренко

~пробы Зимницкого

=пробы Реберга–Тареева

}

Туберкулинодиагностика в ранней диагностике нефротуберкулеза{

~не имеет существенного значения

=имеет важное значение

~должна приниматься во внимание

~ малоинформативна

}

Основным путем выявления туберкулеза мочеполовой системы является{

~обследование контактов

=обращение к врачу

~систематическая постановка туберкулиновых проб

~исследование анализа мочи

~проведение обзорной рентгенографии органов брюшной полости

}

Для выявления больных туберкулезом мочевой системы особое внимание следует обращать на лиц{

~с опухолью почек

~с аномалией развития мочевой системы и с хроническими
воспалительными

заболеваниями почек

~с мочекаменной болезнью

~с нефрозом

=с заболеваниями туберкулезом других органов

}

При обследовании больных с подозрением на туберкулез мочевой системы
вспомогательное значение имеет{

~рентгенологический метод

~микробиологический метод

~серологический метод

=провокационная туберкулиновая проба

}

При лечении нефротуберкулеза у детей раннего возраста применяют повышение дозы специфических препаратов, что обусловлено {

~распространенностью туберкулезного процесса

=высокой экскрецией препарата через мочевые пути

~непереносимостью препаратов

~устойчивостью микобактерии туберкулеза

}

Понижение дозы противотуберкулезных препаратов у больных туберкулезом мочеполовой системы применяют в случае {

=нарушения функции почек

~распространенного процесса

~ при устойчивости микобактерии

~ при генерализации процесса

}

Основная цель патогенетической терапии при мочеполовом туберкулезе - это {

~уменьшить интенсивность воспаления

=препятствовать возникновению стеноза мочевых путей

~уменьшить аллергическое действие противотуберкулезных препаратов

~уменьшить токсическое действие противотуберкулезных препаратов

}

Применение антибиотиков широкого спектра действия при туберкулезе мочеполовой системы обусловлено {

=сочетанием специфической и неспецифической патологии мочевой системы

~наличием клиники пиелонефрита

~наличием признаков мочекаменной болезни

~наличием клиники гломерулонефрита

}

Основными хирургическими методами, применяющимися при лечении туберкулеза мочевых органов, являются {

=органосохраняющие операции

~нефрэктомия

~наложение уретерцистонастомоза

~ не рекомендуется оперативное вмешательство

}

Показаниями к проведению операций при туберкулезе мочевой системы являются {

=наличие кисты или деструкции в пораженной почке

~появление микобактерий туберкулеза в моче

~обнаружение малого мочевого пузыря

~отсутствие или резкое снижение функции органа

}

Основными противопоказаниями к проведению операций при туберкулезе мочевой системы являются {

~большая распространенность специфического процесса, в том числе и в других органах

=хроническая почечная недостаточность (ХПН)

~активный туберкулез почек

~ возрастные ограничения

}

Длительность лечения туберкулеза мочевой системы должна быть не менее {

~6 месяцев

=9 месяцев

~12 месяцев

~18-24 месяцев

~более 2 лет

}

После завершения основного курса лечения больные туберкулезом мочеполовой системы {

=нуждаются в санаторном лечении

~санаторное лечение не обязательно

~в санаторном лечении не нуждаются

~санаторное лечение желательно

}

Основной путь проникновения микобактерий туберкулеза в кости и суставы - это {

~лимфогенный путь из внутригрудных лимфатических узлов

~лимфогенный путь из очага в легочной ткани

=гематогенный путь

~контактный путь при переходе инфекции с мягких тканей на костную

}

Самая частая форма костно-суставного туберкулеза —это {

=туберкулезный спондилит

~туберкулез тазобедренного сустава

~туберкулез коленного сустава

~туберкулезный синовит

}

Ранний клинический признак туберкулезного спондилита –это {

~ боль в области позвоночника при ходьбе

~ограничение подвижности в области позвоночника

=боль в области позвоночника в покое

~нарушение функции тазовых органов

}

Самое частое осложнение при туберкулезном спондилите –это {

=параплегия нижних конечностей

~кровотечение

~туберкулезный менингит

~натечный абсцесс

}

Ранний и характерный клинический признак туберкулеза тазобедренного сустава –это {

=ограничение подвижности в суставе

~боль в суставе при нагрузке

~боль в суставе в покое

~гиперемия кожи над суставом

~отечность в области сустава

}

Ранний и характерный клинический признак туберкулеза коленного сустава – это {

~повышение температуры тела

~боль в суставе в покое

=появление болей при физической нагрузке

~отечность кожи в области сустава

}

Наиболее частым осложнением при туберкулезе суставов является{

=деформация сустава

~ограничение подвижности сустава

~ образование свища

~ образование отека

}

Наиболее информативным методом диагностики костно-суставного туберкулеза–это{

~туберкулинодиагностика

=рентгенологическое исследование

~бактериологическое исследование

~лабораторные анализы крови и ее плазмы

}

В острой фазе течения процесса при костно-суставном туберкулезе рационально провести лечение сочетанием{

=изониазида =рифампицина и стрептомицина

~изониазида =стрептомицина и этамбутола

~изониазида =рифампицина и тизамида

~изониазида=этамбутола и рифампицина

}

Лечение больного костно-суставным туберкулезом осуществляется на принципе{

~санаторный +стационарный +диспансерный

~диспансерный +санаторный +стационарный

~диспансерный +стационарный +санаторный

=стационарный +санаторный +диспансерный

}

Оптимальные сроки комплексного лечения больных костно-суставным туберкулезом составляют {

~около 6 месяцев

~около 9 месяцев

~около 1 года

~около 1.5 лет

=около 2 лет

}

Больные туберкулезом костей и суставов в острой фазе течения заболевания наблюдаются {

~по I группе диспансерного учета

~по 0 группе диспансерного учета

=по I а группе диспансерного учета

~по II группе диспансерного учета

}

В период затихания специфического процесса больные с костно-суставным туберкулезом наблюдаются {

~по II группе диспансерного учета

~по 0 группе диспансерного учета

=по Ib группе диспансерного учета

~по III группе диспансерного учета

}

Основной путь проникновения микобактерий туберкулеза в орган зрения - это {

~лимфогенный, из очага поражения в периферических лимфоузлах

~гематогенный, из первичного очага в легочной ткани

=гематогенный, при распространении инфекции по кровеносным сосудам (период бактериемии)

}

Наиболее частая локализация процесса туберкулеза глаз - это

~туберкулез конъюнктивы глаз

~туберкулезный кератит и склерит

~туберкулезный иридоциклит

=туберкулезный увеит

~туберкулезный хориоретинит

}

Наиболее характерный клинический симптом болезни при туберкулезном поражении глаз –это {

~боль и зуд в глазу

=снижение зрения

~гиперемия склер

~чувство давления на глаз

}

Туберкулез глаз обычно выявляется {

~при туберкулинодиагностике

~при диспансеризации населения

=при обращаемости в связи со снижением зрения

}

Туберкулез глаза чаще всего сочетается {

- ~с очаговым туберкулезом легких
- ~диссеминированным туберкулезом легких
- =туберкулезом внутригрудных лимфоузлов
- ~ туберкулезным менингитом

}

Для диагностики специфического поражения органа зрения рационально использовать пробу{

- =со стандартным туберкулином (2 ТЕ внутрикожно)

- ~Гринчара - Карпиловского

- ~ проба Коха

- ~со стандартным туберкулином внутрикожно в разведении 1:10, 1:100, 1:1000

}

Оптимальным вариантом лечебных мероприятий при туберкулезе глаз является{

- ~общее лечение противотуберкулезными препаратами

- =общее и местное лечение противотуберкулезными препаратами

- ~местно лечение только противотуберкулезными препаратами

- ~ оперативное вмешательство

}

Применение патогенетических средств при лечении туберкулеза глаз позволяет{

- ~уменьшить побочное действие химиопрепаратов

- ~снизить воспалительную реакцию

- =уменьшить развитие рубцовых изменений в структурах органа зрения

- ~уменьшить аллергическое действие химиопрепаратов

}

Верификация диагноза туберкулеза глаз проводится {

~в туберкулезном санатории

=в специализированной туберкулезной больнице

~в туберкулезном диспансере

~ в поликлинике

}

Больные, страдающие туберкулезом глаз, должны наблюдаться {

~фтизиатром

~офтальмологом

=фтизиатром и офтальмологом

~ хирургом

}

При наличии у инфицированного туберкулезом ребенка снижения зрения и боли в глазу фтизиопедиатр должен {

=направить ребенка к фтизиоокулисту

~направить к окулисту

~поставить туберкулиновые пробы

~провести рентгенологическое обследование органов грудной клетки, а также черепа

}

Основным путем проникновения инфекции в периферические лимфатические узлы является {

=лимфогенный

~гематогенный

~контактный

~ внутриутробный

}

Туберкулез периферических лимфоузлов в структуре внелегочных форм составляет {

~ 3%

~ 10-20%

~27%

=35%

}

Среди внелегочных форм туберкулезный лимфаденит занимает {

~первое место

=второе место

~третье место

~четвертое место

~пятое место

}

При туберкулезе периферических лимфатических узлов чаще всего поражается {

~подмышечная группа

=шейная группа

~паховая группа

~подчелюстная группа

}

Начало заболевания при туберкулезе периферических лимфатических узлов {

обычно

~острое

~подострое

=постепенное

~хроническое

}

Основным клиническим признаком туберкулеза периферических лимфатических узлов является{

=увеличение лимфатических узлов с признаками периаденита

~увеличение лимфатических узлов без признаков периаденита

~отечность кожи в области лимфаденита

~болезненность при пальпации лимфоузла

}

Периферический лимфатический узел считается увеличенным, если его размеры составляют{

~3-4 мм '

=6-7 мм

~8-9 мм

~10-12 мм

~более 12 мм

}

После завершения основного курса лечения больные туберкулезом мочеполовой системы{

=нуждаются в санаторном лечении

~санаторное лечение не обязательно

~в санаторном лечении не нуждаются

~санаторное лечение желательно

}

Основной путь проникновения микобактерий туберкулеза в кости и суставы - это{

~лимфогенный путь из внутригрудных лимфатических узлов

~лимфогенный путь из очага в легочной ткани

=гематогенный путь

~контактный путь при переходе инфекции с мягких тканей на костную

}

Самая частая форма костно-суставного туберкулеза –это {

=туберкулезный спондилит

~туберкулез тазобедренного сустава

~туберкулез коленного сустава

~туберкулезный синовит

}

Ранний клинический признак туберкулезного спондилита –это {

~ боль в области позвоночника при ходьбе

~ограничение подвижности в области позвоночника

=боль в области позвоночника в покое

~нарушение функции тазовых органов

}

Самое частое осложнение при туберкулезном спондилите –это {

=параплегия нижних конечностей

~кровотечение

~туберкулезный менингит

~натечный абсцесс

}

Ранний и характерный клинический признак туберкулеза тазобедренного сустава –это {

=ограничение подвижности в суставе

~боль в суставе при нагрузке

~боль в суставе в покое

~гиперемия кожи над суставом

~отечность в области сустава

}

Ранний и характерный клинический признак туберкулеза коленного сустава – это {

~повышение температуры тела

~боль в суставе в покое

=появление болей при физической нагрузке

~отечность кожи в области сустава

}

Наиболее частым осложнением при туберкулезе суставов является {

=деформация сустава

~ограничение подвижности сустава

~ образование свища

~ образование отека

}

Наиболее информативным методом диагностики костно-суставного туберкулеза–это {

~туберкулинодиагностика

=рентгенологическое исследование

~бактериологическое исследование

~лабораторные анализы крови и ее плазмы

}

В острой фазе течения процесса при костно-суставном туберкулезе рационально провести лечение сочетанием {

=изониазида =рифампицина и стрептомицина

~изониазида =стрептомицина и этамбутола

~изониазида =рифампицина и тизамида

~изониазида=этамбутола и рифампицина

}

Туберкулез периферических лимфатических узлов чаще всего сочетается {

~с туберкулезом легких

~с костно-суставным туберкулезом

~с туберкулезом почек

=с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов

}

Наиболее частым осложнением туберкулезного лимфаденита является {

=образование свищей

~кровотечение

~аллергические реакции

~образование язв

}

У детей туберкулез периферических лимфатических узлов чаще протекает {

~в гиперпластической форме

~в фиброзной форме

=в казеозной форме

~ в опухолевой форме

}

При лечении больных туберкулезом периферических лимфатических узлов в острой фазе его течения рационально использовать комбинацию следующих противотуберкулезных препаратов {

~изониазида +стрептомицина

~изониазида +тизамида

=изониазида +стрептомицина +рифампицина

~ рифампицина

}

Длительность основного курса лечения должна быть не менее {

~6 месяцев

=9 месяцев

~1 года

~1.5 лет

~2.0 лет

}

Местное лечение противотуберкулезными препаратами при туберкулезе периферических лимфатических узлов заключается {

~в их электрофорезе

~в аппликации препаратов

~в применении их в виде мазей

=в инъекциях препаратов в ткань лимфоузлов и в окружающую клетчатку

}

Специфический процесс при туберкулезном менингите локализуется преимущественно {

~в веществе головного мозга

=в мозговых оболочках

~в стволе головного мозга

~ в нервных окончаниях

}

Туберкулезный менингит чаще встречается у детей, его удельный вес среди всех локализаций туберкулеза у детей составляет {

~около 0.1%

=около 0.5%

~около 1%

~около 2%

}

Наиболее часто болеют туберкулезным менингитом дети в возрасте {

~до 1 года

=от 1 до 2 лет

~от 2 до 3 лет

~от 5 до 7 лет

~от 7 до 10 лет

}

Дети раннего возраста чаще заболевают туберкулезным менингитом {

=из-за несформировавшегося послевакцинального иммунитета

~из-за несформировавшегося общего иммунитета

~из-за высокой реактивности организма

~из-за высокой сосудистой проницаемости ~из-за незрелости центральной нервной системы

}

Для туберкулезного менингита у детей раннего возраста более характерно {

~постепенное начало заболевания

=острое начало заболевания

~бессимптомное начало заболевания

~ хроническое течение заболевания

}

Начальный признак туберкулезного менингита –это {

~вялость

~снижение аппетита

=головная боль

~повышение температуры тела

}

Наиболее характерный ранний симптом туберкулезного менингита –это {

~ снижение слуха

~снижение зрения

=повышение сухожильных рефлексов

~ригидность затылочных мышц

}

Основным методом в дифференциальной диагностике туберкулезного менингита от

других заболеваний центральной нервной системы является {

~исследование периферической крови

~биохимическое исследование крови

=исследование спинномозговой жидкости

~ исследование мочи

}

Показаниями к проведению спинномозговой пункции являются {

~потеря сознания

~нарушение иннервации черепномозговых нервов

~головная боль

=наличие менингеальных симптомов

}

В анализе спинномозговой жидкости при туберкулезном менингите обычно наблюдается{

- ~повышение содержания белка
- =снижение содержания сахара
- ~увеличение числа нейтрофилов
- ~ повышение содержания сахара

}

В качестве дополнительных методов исследования при туберкулезном менингите следует провести{

- =исследование глазного дна
- ~снимок черепа и позвоночника
- ~туберкулиновые пробы
- ~аудиометрию

}

Туберкулезный менингит необходимо дифференцировать с серозным менингитом, гнойным менингитом и менингеальной формой полиомиелита{

- ~из-за сходства клинических проявлений
- ~из-за одинакового для них начала заболевания
- =из-за сходства состава спинномозговой жидкости
- ~из-за выраженности менингеальных симптомов

}

При лечении больных туберкулезным менингитом наилучшие результаты достигаются при применении следующего сочетания противотуберкулезных химиопрепаратов{

- =изониазид +рифампицин+стрептомицин
- ~изониазид +рифампицин+этамбутол

~изониазид +тизамид+стрептомицин

~изониазид +тизамид+этамбутол

~изониазид +протионамид+этамбутол

}

Для местного лечения интралимбально субокципитально вводятся растворы{

=изониазида

~рифампицина

~ стрептомицина

~этамбутола

}

Лица, перенесшие туберкулезный менингит, наблюдаются{

~по II группе диспансерного учета

~по III группе диспансерного учета

~ по Ia группе диспансерного учета

=по III группе диспансерного учета

} Туберкулезные изменения в почке локализуются преимущественно{

~в мозговом слое

=в корковом слое

~в чашечно-лоханочной системе

~ в паренхиме

}

Частота поражения мочеполовой системы туберкулезом составляет{

~около 10%

~около 5%

=около 2.5%

~около 1.5-2.0%

}

Сочетание туберкулеза мочеполовой системы со специфическими поражениями других органов{

~не наблюдается

=наблюдается нередко

~иногда встречается

~часто встречается

}

Наиболее частой формой туберкулеза мочевой системы является{

~туберкулезный папиллит

~фиброзно-кавернозная

~кавернозная

=паренхиматозная (туберкулез почечной паренхимы)

}

Наиболее характерными для туберкулеза мочевой системы клиническими признаками являются{

~ноющие боли в области поясницы

~изменения в моче в виде гематурии ~острая боль в животе

~субфебрилитет

=изменения в моче в виде лейкоцитурии

}

Симптомы интоксикации для клинического течения нефротуберкулеза{

~характерны

~не характерны

=встречаются не всегда

~ часто встречаются

}

Основными методами выявления туберкулеза мочевой системы являются {

~рентгенологический

=микробиологический

~туберкулиновых проб

~клинический

}

Среди инструментальных методов исследования наибольшее значение для распознавания туберкулеза мочевого пузыря имеет {

~ретроградная пиелография

=цистоскопия

~внутривенная урография

~инфузионная урография

~хромоцистография

}

Внутривенная урография для диагностики туберкулеза почек {

~является единственным методом диагностики

=не является единственным методом диагностики

~является малоэффективным методом диагностики

~ не применяют для диагностики

}

С целью определения нарушения функции почек радиоизотопная ренография {

=может быть применена

~не применяется

~применяется иногда

~ малоинформативна

}

0 функциональном состоянии почек наиболее полное суждение может быть получено с помощью {

~анализа мочи

~анализа мочи по Нечипоренко

~пробы Зимницкого

=пробы Реберга–Тареева

}

Общая длительность наблюдения за лицами, перенесшими туберкулезный менингит, составляет {

~12 месяцев

~2 года

=3 года

~ 5 лет

~ 10 лет

}

Лечебная тактика при туберкулезе определяется {

~возрастом больных

~клинической формой туберкулеза и наличием деструктивных изменений

~наличием массивного бактериовыделения

~наличием сопутствующих заболеваний и их характером

}

100т

ТЗ с выбором нескольких правильных ответов

Необходимость стационарного этапа лечения больного туберкулезом определяется {

~%25% необходимостью всестороннего обследования с уточнением диагноза, распространенности и локализации процесса, осложнений и выявления сопутствующих заболеваний

~%25% возможностью провести интенсивную терапию

~%25% возможностью более современного подбора лечебных средств и методов

~%25% лучшими условиями для контроля за проведением лечения

~%-100% возможностью контролировать поведение больного

}

Продолжительность пребывания больного в стационаре определяется {

~%25% характером туберкулезного процесса и его осложнениями

~%25% наличием сопутствующих заболеваний

~%25% скоростью наступления положительных рентгенологических сдвигов и скоростью прекращения бактериовыделения

~%25% переносимостью химиотерапии

~%-100% непереносимостью химиотерапии

}

Переход на амбулаторный этап лечения больного туберкулезом возможен {

~%33.33333% при хорошей или удовлетворительной переносимости не менее двух противотуберкулезных химиопрепаратов

~%33.33333% после прекращения бактериовыделения

~%33.33333% при наметившейся в ходе лечения положительной рентгенологической динамики в течении процесса, позволяющей прогнозировать достижение значительного улучшения в конце основного курса химиотерапии

~%-100% до прекращения бактериовыделения

}

Для диагностики туберкулеза мочевой системы особенно у детей и подростков следует учитывать {

~%33.33333% наличие контакта с больными туберкулезом

~%33.33333% ранее перенесенный внелегочный туберкулез

~%33.33333% текущий туберкулез других локализации

~%-100% наследственный фактор

}

Исходы туберкулеза мочевой системы –это {

~%25% нефролитиаз

~%25% рубцовое изменение мочеточника с нарушением оттока мочи

~%25% гидронефроз

~%25% переход в неспецифический нефрит

~%-100% гидроптоз

}

Основными критериями излечения туберкулеза мочевой системы являются {

{

~%25% прекращения бактериовыделения

~%25% прекращения лейкоцитурии

~%25% нормализации функциональных показателей почек

~%-100% стеноза мочеточника

~%25% кальцинатов в паренхиме почек

}

Туберкулез периферических лимфатических узлов обычно приходится дифференцировать {

~%33.33333% с опухолевым их поражением (лимфома Ходжкина, лимфосаркома и т.д.)

~%33.33333% с неспецифическим лимфаденитом

~%33.33333% с поражением лимфатических узлов при саркоидозе

~%-100% с язвенной болезнью

}

Методами лечения костно-суставного туберкулеза являются {

~%-100% консервативный

~%33.33333% медикаментозный

~%33.33333% ортопедический

~%33.33333%хирургический

}

В отличие от туберкулезного менингита серозному менингиту более свойственно: {

~%50% Острое начало

~%-100% Постепенное начала

~%50% Нередкое благоприятное течение со спонтанным излечением

~%-100% Неблагоприятное течение с возможным летальным исходом

}

В отличие от туберкулезного менингита для гнойного менингита характерно : {

~%50% Острое начало

~%-100% Постепенное начало

~%-100% Чаще благоприятное течение со спонтанным излечением

~%50% Неблагоприятное течение с возможным летальным исходом

}

